GRUNDLAGEN · KAPITEL 1 UND 2

Verhaltenssüchte im ICD-11

Nur zwei Formen gelten im ICD-11 als Verhaltenssucht im engeren Sinn. Für die Beratung zählen alle Formen mit Kontrollverlust und Leidensdruck.

im Leitfaden | ausgeschlossen

ICD-11, Code 6C5×

Störung durch Suchtverhalten

Glücksspiel
6C50 · ICD-10: F63.0
Beratung durch SD Werdenberg

Gaming
6C51
Eigener Leitfaden Mediensucht

ICD-11, Code 6C7×

Impulskontrollstörung

Zwanghaftes Sexualverhalten
6C72 (CSBD)
Pornografie-Nutzungsstörung gilt als Variante. Entscheidend sind Kontrollverlust, Leidensdruck und Beeinträchtigung über längere Zeit.

Social Media, Streaming, Smartphone
Eigener Leitfaden Mediensucht

Keine eigene Kategorie

Praxisrelevant, Einordnung offen

Kaufsucht
ICD-10: F63.8 / F63.9
ICD-11: als „andere näher bezeichnete Störung durch Suchtverhalten" vorgeschlagen

Arbeitssucht

Sportsucht

Weitere: Beziehungssucht, Sammeln und Horten (Kurzmodul)

ICD-10: fasst Verhaltenssüchte weitgehend unter F63 (abnorme Gewohnheiten und Impulskontrolle). Die 3-aus-6-Regel gilt nur für Substanzabhängigkeit.

Finanzierung: hängt nicht von der Kategorie ab, sondern von der medizinischen Behandlungsbedürftigkeit.

ENTSTEHUNG · KAPITEL 4

Wie eine Verhaltenssucht entsteht und sich hält

Das Bedingungsgefüge: Was macht anfälliger?

Person
Neurotizismus, Impulsivität, materielle Werteorientierung

Umfeld
Familie, Ausbildung, Beruf

Angebot
Automaten, Games, Kaufangebote, ständige Verfügbarkeit

Der Teufelskreis: Was hält das Verhalten aufrecht?

1	2	3	4	5
Auslöser	**Drang**	**Verhalten**	**Erleichterung**	**Folgen und Scham**
Gefühl, Situation, Angebot	Gedanken kreisen, Unruhe	Kaufen, arbeiten, trainieren, Sexualverhalten	Kurzfristig besser, Gefühl verdrängt	Schulden, Streit, Zeitverlust, Schuld
Stimuluskontrolle	Reaktionsverzögerung, Craving-Skills	Selbstbeobachtung, Verhaltensanalyse	Alternativen aufbauen, Wochenstruktur	Scham besprechen, Schuldenmanagement

› › › ›

Scham und Anspannung sind der nächste Auslöser: der Kreis beginnt von vorn

Mit der Zeit: Das Belohnungssystem lernt das Verhalten. Kontrollverlust, Toleranz und Entzugserscheinungen wie Unruhe oder Reizbarkeit entstehen. Alternative Strategien werden seltener genutzt.

Die grün umrandeten Felder zeigen, wo Techniken der Beratung ansetzen (Vorschlag, Kap. 6.4).

Wo die Beratung endet

Der Behandlungsauftrag entscheidet, nicht die Methode. „Psychologisch arbeiten" ist nicht automatisch Psychotherapie.

Fachstelle Sucht SDS

1 Suchtbezogene Beratung

Wie funktioniert das Verhalten, wie lässt es sich verändern?

Techniken: Psychoedukation, Motivierende Gesprächsführung, Selbstbeobachtung, Verhaltensanalyse, Stimuluskontrolle, Craving-Skills, Rückfallprophylaxe

2 Psychosoziale Begleitung

Welche psychischen, sozialen und lebenspraktischen Faktoren halten es aufrecht?

Techniken: Geld- und Schuldenmanagement, Wochenstruktur, Einbezug des Umfelds, einfache Strategien für Gefühle und Stress

Grenzbereich: kognitive Umstrukturierung nur als Anregung, vertiefte Gefühlsarbeit mit Vorsicht

Psychotherapie

3 Psychotherapeutische Behandlung

Welche psychische Störung liegt vor, wie wird sie gezielt behandelt?

Beispiele: Exposition mit Reaktionsverhinderung, systematische Schema-Arbeit, Traumabehandlung. Zuweisung über Hausärztin oder Hausarzt, OKP im Anordnungsmodell.

Signale zur Weitervermittlung

Sofort

Akute Suizidalität oder konkrete Pläne: Krisenprozedere

Ärztliche Abklärung

Verdacht auf Manie oder Psychose, Gesundheitsrisiko (z. B. Anabolika, Verletzungen)

Psychotherapeutische Abklärung

Schwere Depression, ausgeprägte Angst, Trauma im Vordergrund. Beratung begleitet weiter

Team-Triage

Ziele trotz Mitarbeit über mehrere Sitzungen nicht erreichbar

Information und Verweis

Wunsch der Person nach Bearbeitung der Hintergründe

STAKEHOLDER · KAPITEL 0

Wer an der Beratung beteiligt ist

Die Fachstelle Sucht berät Betroffene, Angehörige, Arbeitgebende und Ausbildende und arbeitet mit Dritten zusammen.

Kapitel 3, 9

Betroffene

Entlastung vom Stigma, verständliche erste Schritte, Orientierung zum Weg

Kapitel 10

Angehörige

Belastung einordnen, nicht-konfrontativ handeln, eigene Grenzen, Finanzen trennen

Kapitel 11

Arbeitgebende, Ausbildende

Auffälligkeiten ansprechen, Gesprächsführung, Rolle und Grenzen

Kapitel 12

Hausärzte und Psychiatrie

Abklärung, Anordnung Psychotherapie, Komorbidität. Rückmeldung nur mit Einwilligung

Kapitel 6, 7, 8

Fachstelle Sucht, Soziale Dienste Sarganserland

Sozialarbeitende mit Suchterfahrung. Beratung, keine Psychotherapie. Intervision, Fallbesprechung und Supervision im Alltag.

Kapitel 0, 12

Träger und Region

SDS, Kanton St. Gallen, Fürstentum Liechtenstein (Amt für Soziale Dienste). Zuständigkeit und Kosten

Kapitel 12

Schuldenberatung, Recht

Verschuldung bei Kaufsucht und Folgen anderer Verhaltenssüchte

Kapitel 12

Online und Selbsthilfe

SafeZone.ch, niederschwellig und anonym. Selbsthilfe: in der Region nichts Belegtes gefunden

Kapitel 12, 13

Kliniken und Notfall

Stationäre Behandlung bei schwerer Ausprägung, Krisendienste, Notrufe